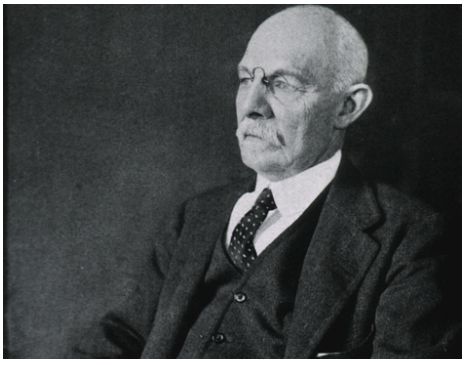
CLASE ESPECIAL

CIRUGÍA ONCOLÓGICA Y SU EVOLUCIÓN

DR. JOSE MANUEL FÁBREGA

PIONEROS Y MODELOS DE FORMACIÓN

- Sir William Halsted (Johns Hopkins): técnica depurada, hemostasia microscópica, guantes de goma, residencia piramidal.
- C. Walton Lillehei (Minnesota): circulación cruzada, primera máquina de circulación extracorpórea, marcapasos; formó a Christian Barnard (1er trasplante cardiaco humano, 1967).
- En Panamá: Dr. Rogelio Arosemena (Georgetown/Mayo) estructuró la residencia bajo el modelo de Blalock en la CSS.



ERA SUPERRADICAL (AÑOS 1970)

- Sin quimioterapia efectiva, la cirugía era la única opción: mastectomía supraradical de Urban-Meer, procedimiento comando (cabeza/cuello) y resección abdominoperineal, todas mutilantes.

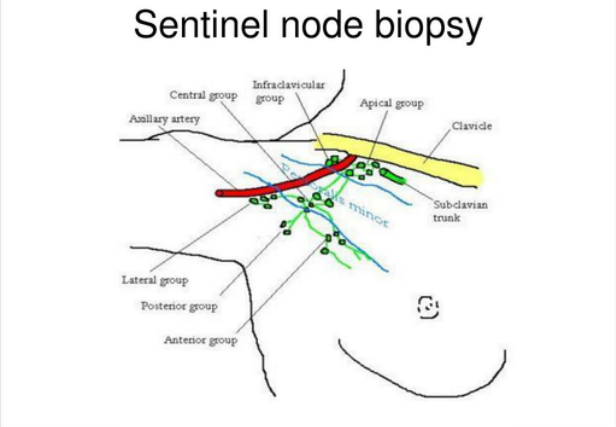


MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

- Los ensayos clínicos aleatorizados reemplazaron la opinión de expertos como estándar para validar nuevas técnicas quirúrgicas y oncológicas.

ERA MODERNA Y MÍNIMAMENTE INVASIVA

- Mastectomía parcial + biopsia de ganglio centinela: sustituyó la linfadenectomía axilar masiva; inyección de azul de isosulfán/ICG/tecnecio-99 para resecar solo 1-3 ganglios, reduciendo linfoedema.



NEOADYUVANCIA E INMUNOTERAPIA

- Neoadyuvancia: quimio/radio/inmunoterapia preoperatoria para erradicar micrometástasis y lograr márgenes R0.
- Inmunoterapia: bloquea checkpoints inmunológicos; pembrolizumab (anti-PD-1) indicado en tumores MSI-High/dMMR.

FUTURO: ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN

- Perfil molecular tumoral (secuenciación de nueva generación) guía terapias dirigidas individualizadas, hacia tratamientos específicos por mutación, no solo por órgano de origen.

